Université de Bejaia
Faculté de Médecine de Bejaia
Module de Sémiologie Médicale

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

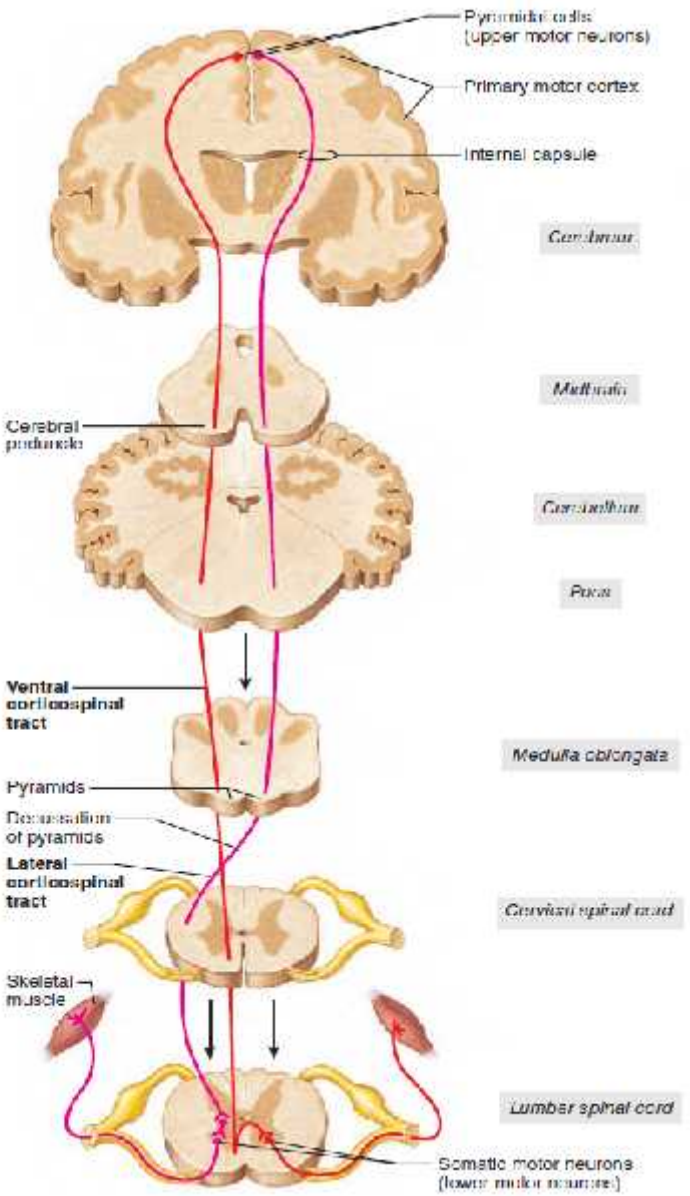
faculté de médecine de béjaia

Sémiologie de la motricité 1

Les Paralysies centrales
Syndrome pyramidal

Dr Terra. Service de médecine interne du CHU Bejaia

Voie cortico-spinale

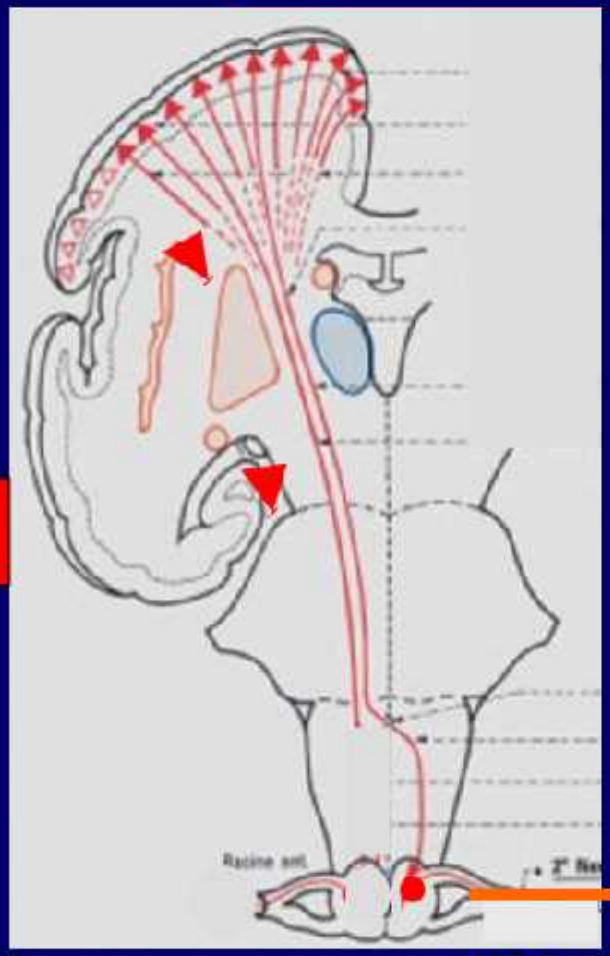


Voies de la Motricité volontaire

1er neurone

sceau cospinal

SNC



Racines

2è motoneurone

Système nerveux périphérique

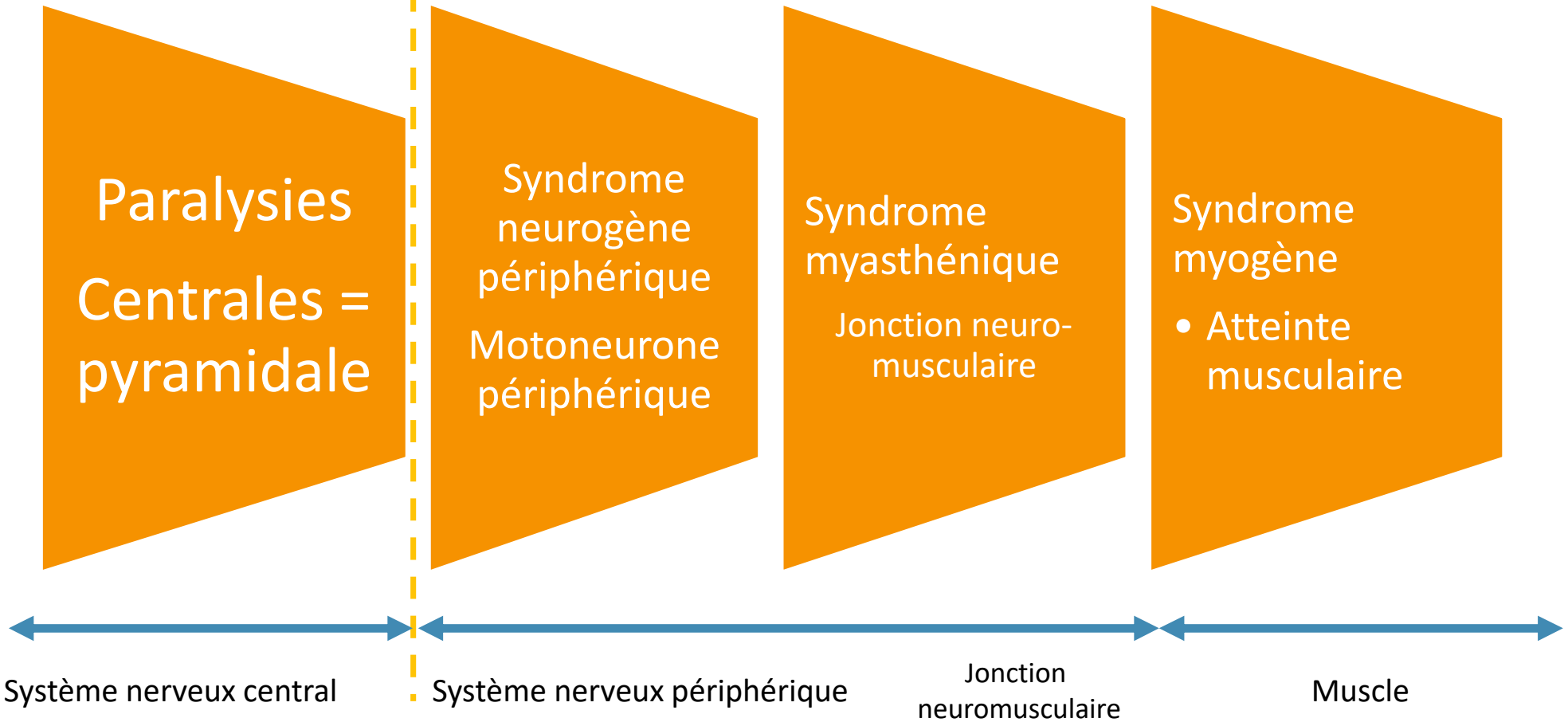
Plexus

Troncs

Muscle

Jonction Neuromusculaire

Syndromes moteurs : Anomalies de la motricité



Sémiologies des paralysies

Définition

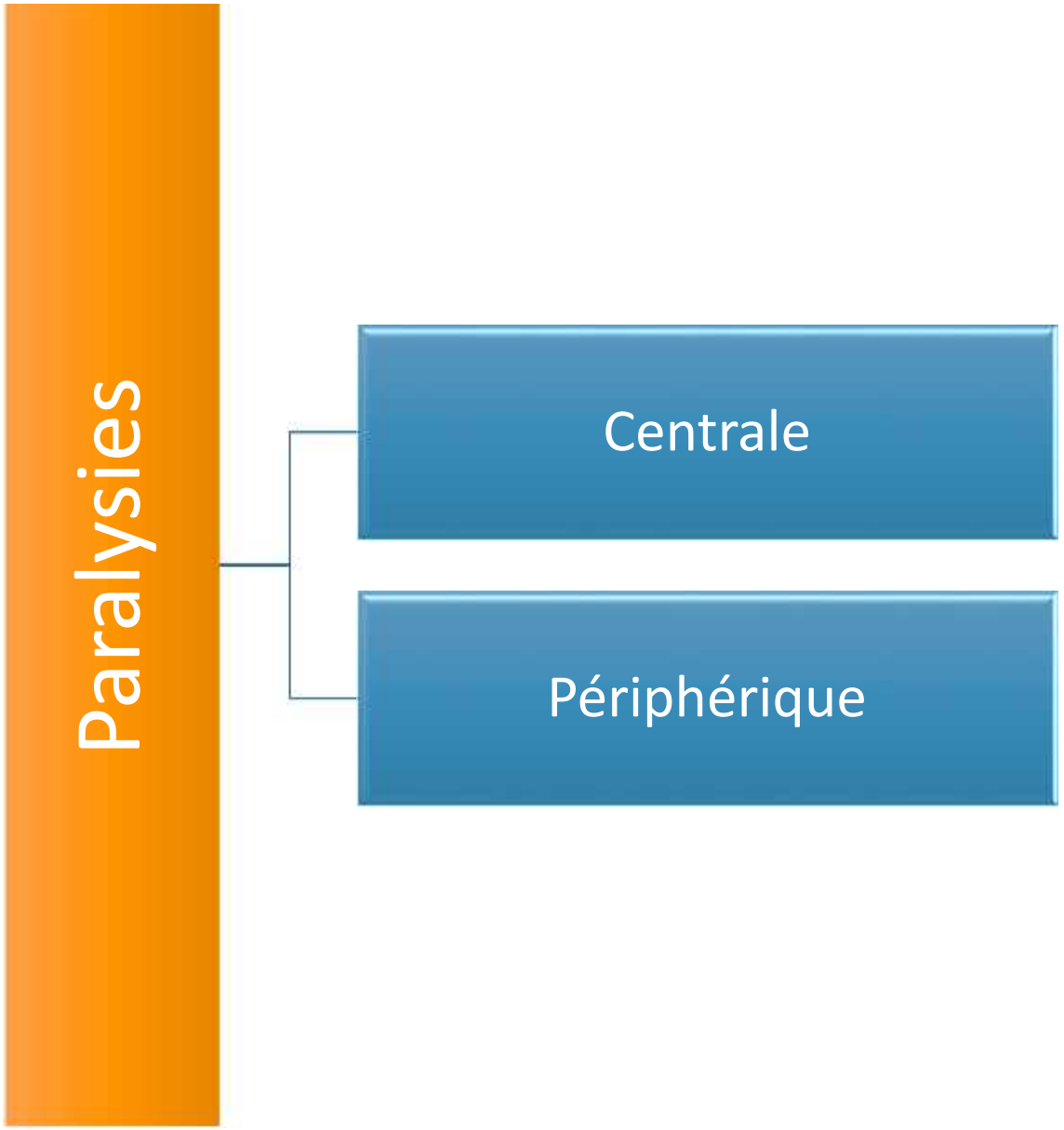
- La paralysie est une diminution ou une abolition de la motricité volontaire.

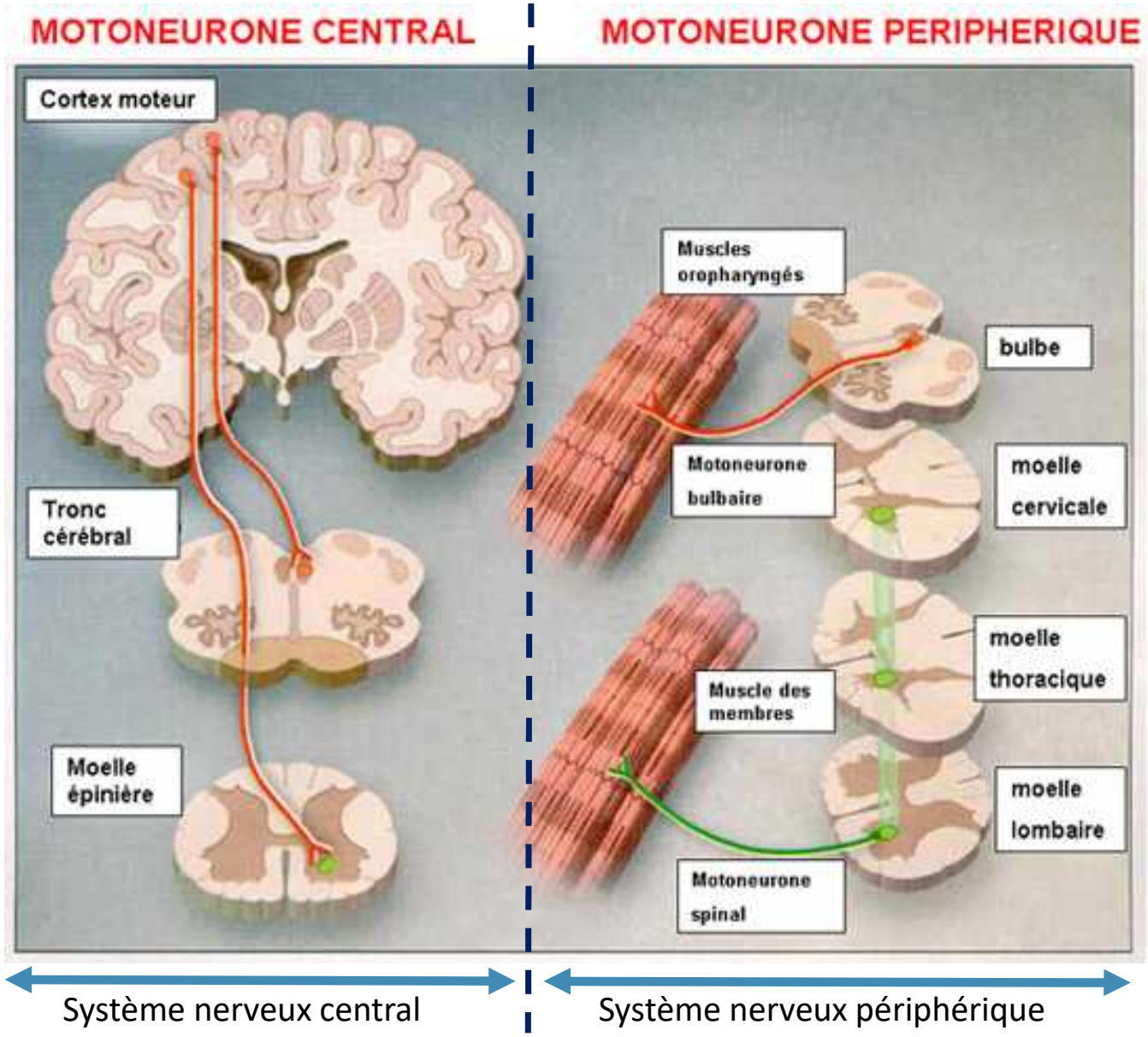
- Parésie : paralysie incomplète

Terminologie :

– Déficit complet : **- plégie**

– Déficit Incomplet : **- parésie**


Paralysies
Centrale
Périphérique


MOTONEURONE CENTRAL
MOTONEURONE PERIPHERIQUE
Cortex moteur
Tronc cérébral
Moelle épinière
Muscles oropharyngés
bulbe
Motoneurone bulbaire
moelle cervicale
moelle thoracique
Muscle des membres
moelle lombaire
Motoneurone spinal
Système nerveux central
Système nerveux périphérique

Sémiologie : syndrome pyramidal

Déficit moteur

- Prédomine sur les **muscles extenseurs** au membres supérieurs
- Prédomine sur les muscles aux **muscles fléchisseurs** au membres inférieurs
- la face : Prédomine sur la partie inférieure





- Le déficit moteur aux membre inférieurs est mis en évidence par ces 2 manoevres



- Déficit aux membres supérieurs mis en évidence par la manouvre de barré

Sémiologie : syndrome pyramidal

- **Hypotonie au stade précoce**
- **Hypertonie +++**
- **Spasticité +++**

Stade de paralysie flasque (phase précoce)

- Absence de toute motricité volontaire
- Prédomine aux extenseurs aux membres supérieurs
- Prédomine aux fléchisseurs aux membres inférieurs

Stade de paralysie spastique

- Fait suite à la phase spastique
- Hypertonie +++ (spasticité)
- Prédomine aux fléchisseurs aux membres supérieurs
- Prédomine aux extenseurs aux membres inférieurs

Hémiplégie (Syndrome pyramidal) : Anomalies des réflexes

Réflexes ostéo-tendineux :

- vifs
- diffusés
- polycinétiques
- extension de la zone réflexogène

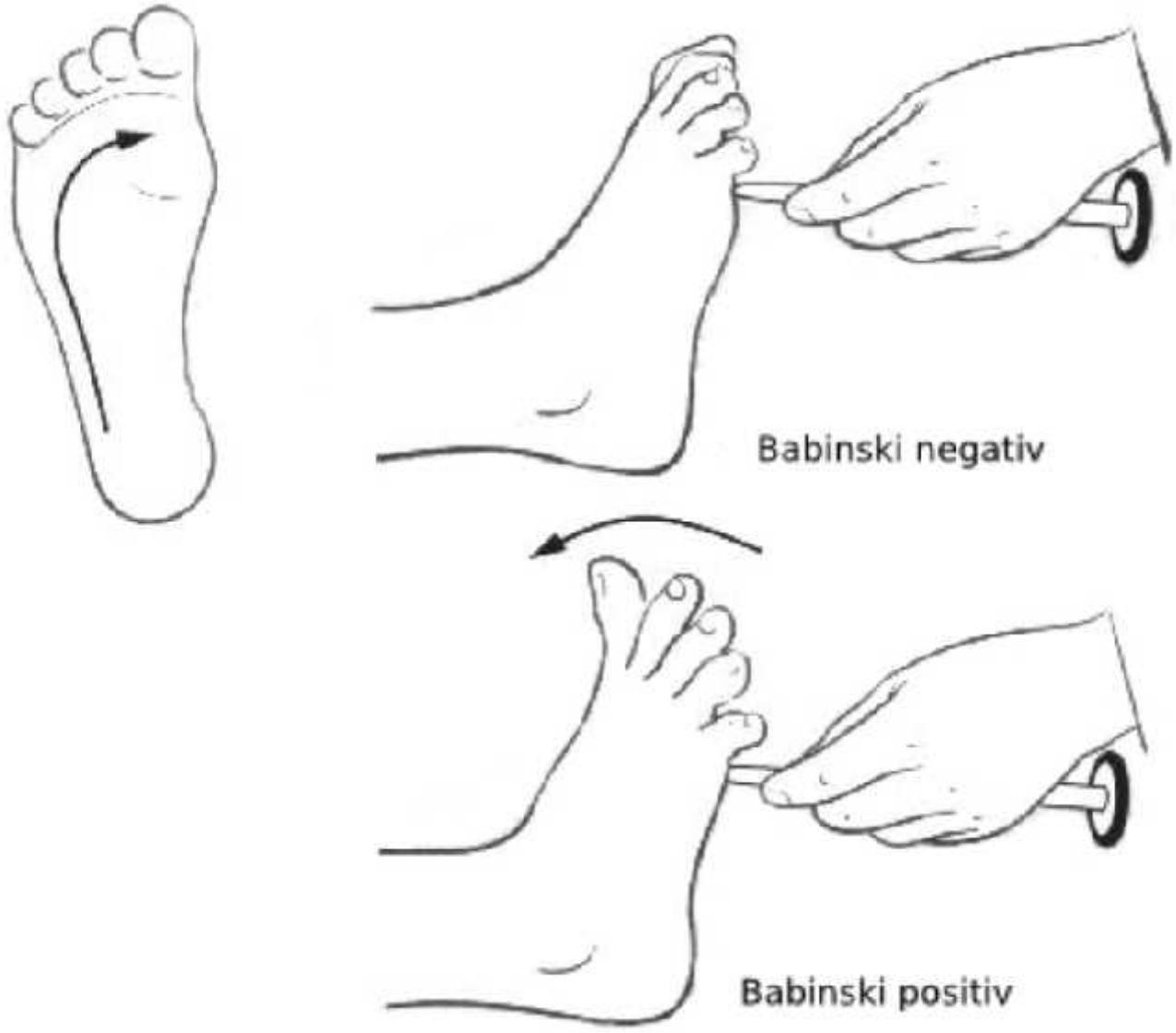
Hémiplégique : marche en fauchant

- Spasticité des muscles fléchisseurs au niveau du membre supérieur
- Spasticité des muscles extenseurs au niveau du membre inférieur

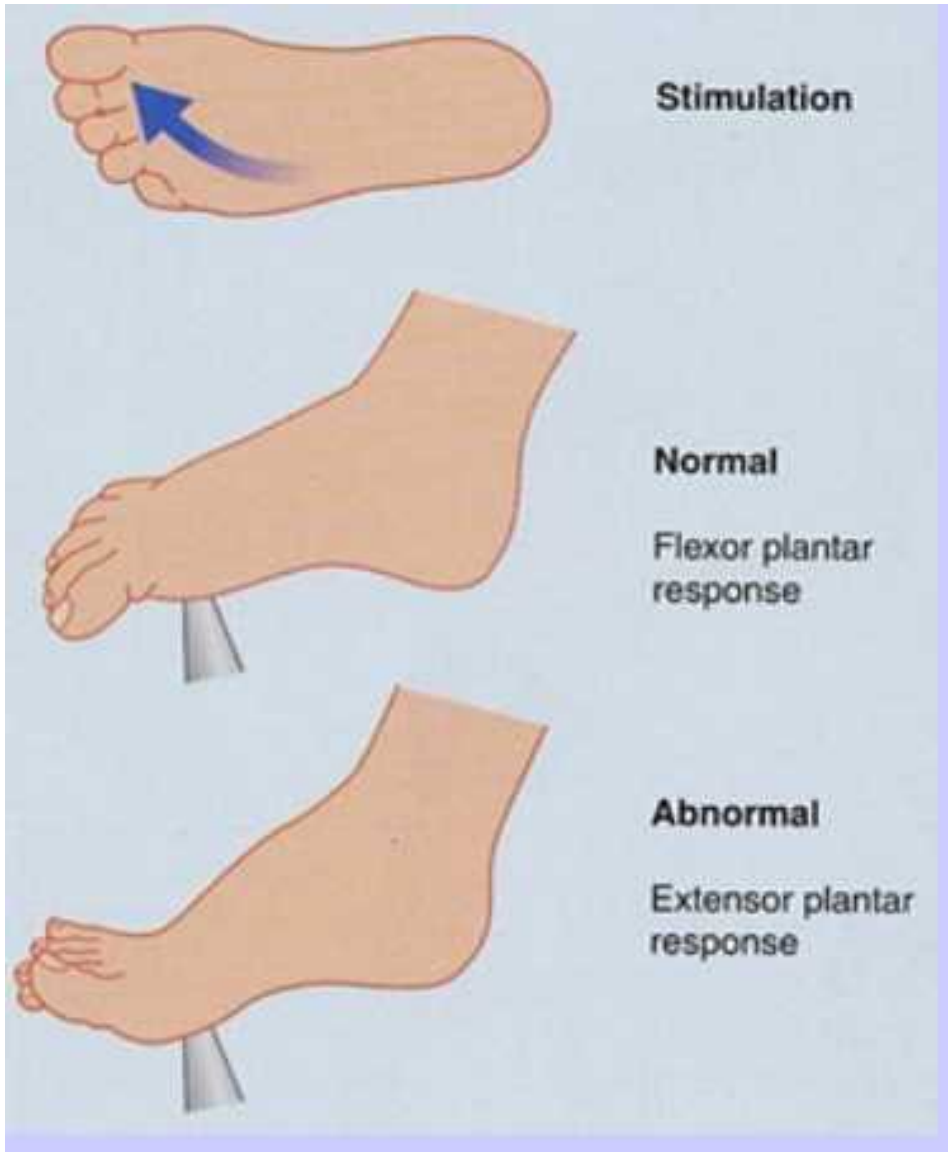


Hémiplégie (Syndrome pyramidal) : Anomalies des réflexes

- Signe de Babinski: extension lente du gros orteil lors de la recherche du réflexe cutané plantaire
- Signe de Hoffman (flexion des doigts lors d'une pression vive sur l'ongle du majeur)
- Abolition des réflexes cutanés abdominaux


Babinski negativ
Babinski positiv

Signe de Babinski

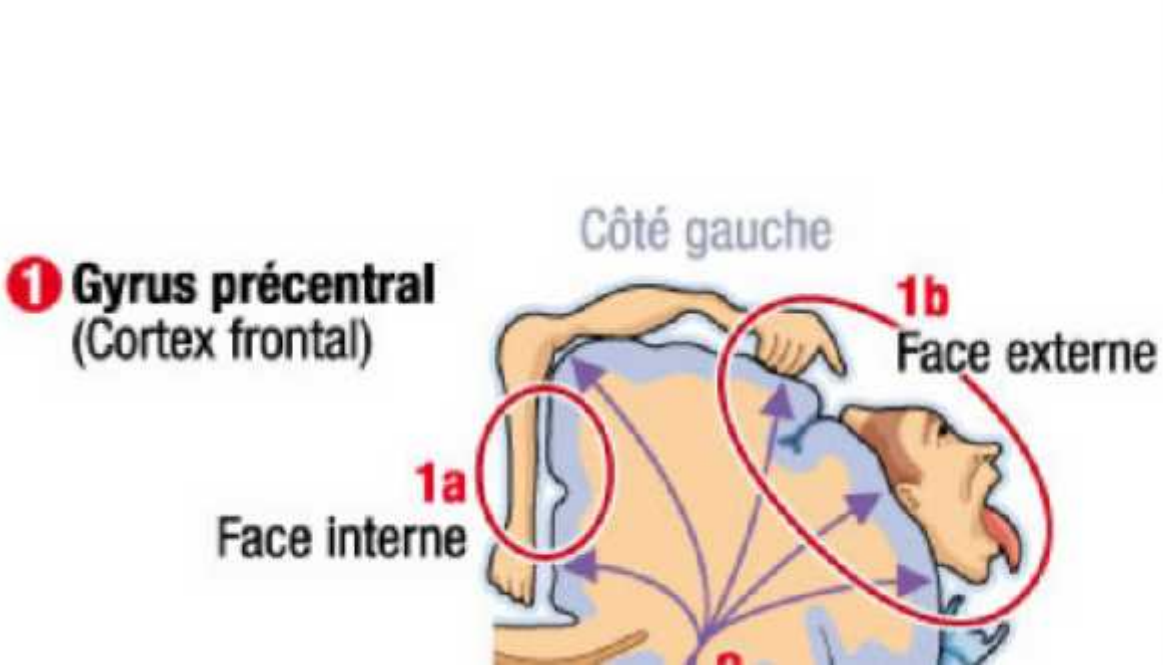


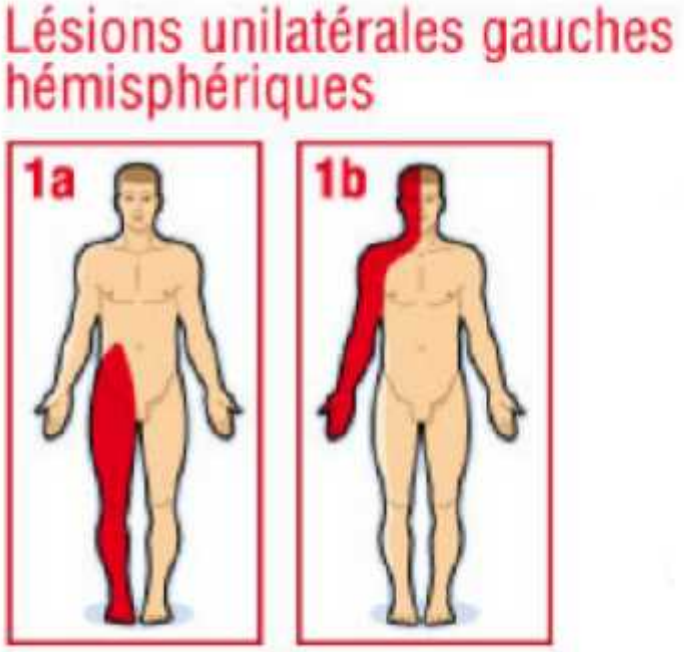
Syndromes topographiques

Syndromes topographiques

Présentations cliniques variables selon la localisation anatomique de la lésion au niveau du système nerveux central

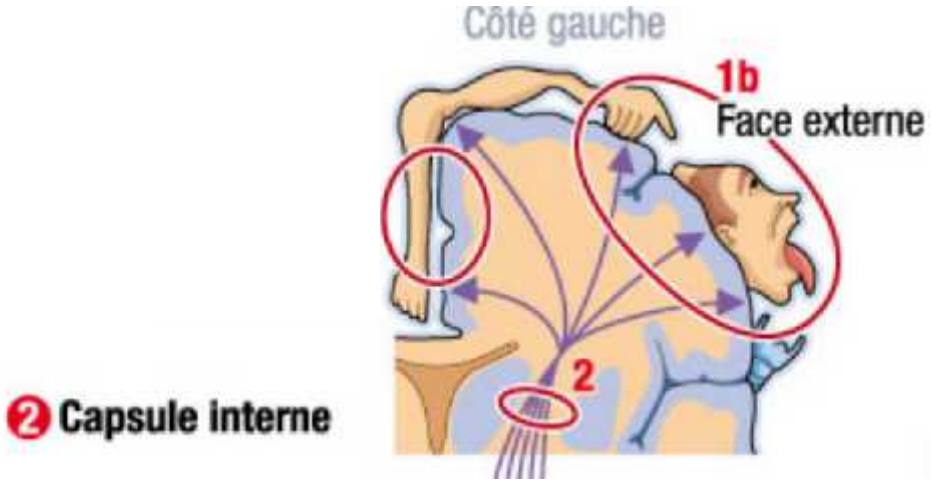
Atteinte pyramidale corticale

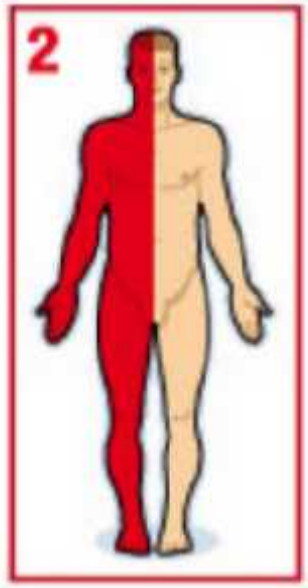




Déficit controlatéral

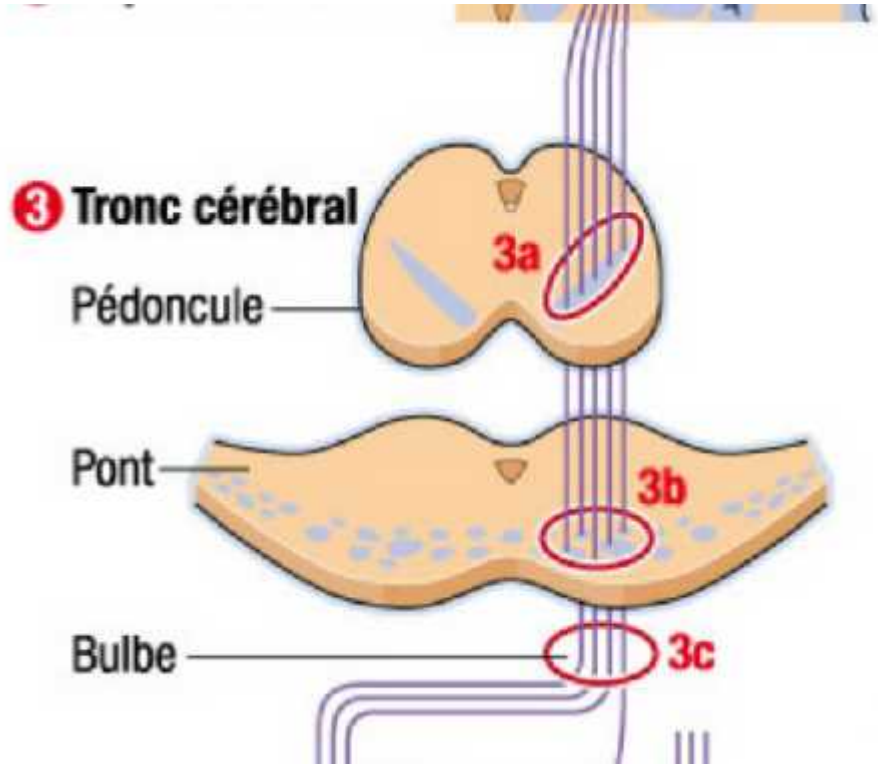
Hémiplégie par attente de la capsule interne

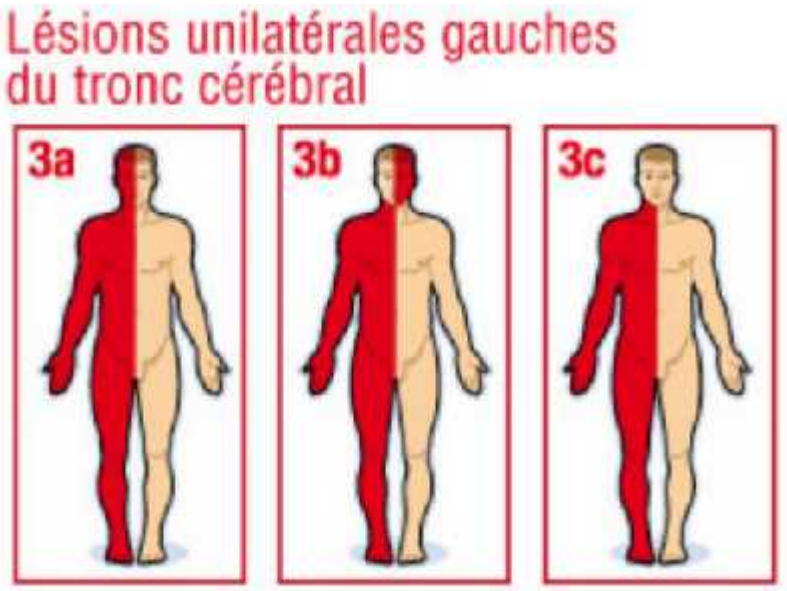




Déficit controlatéral

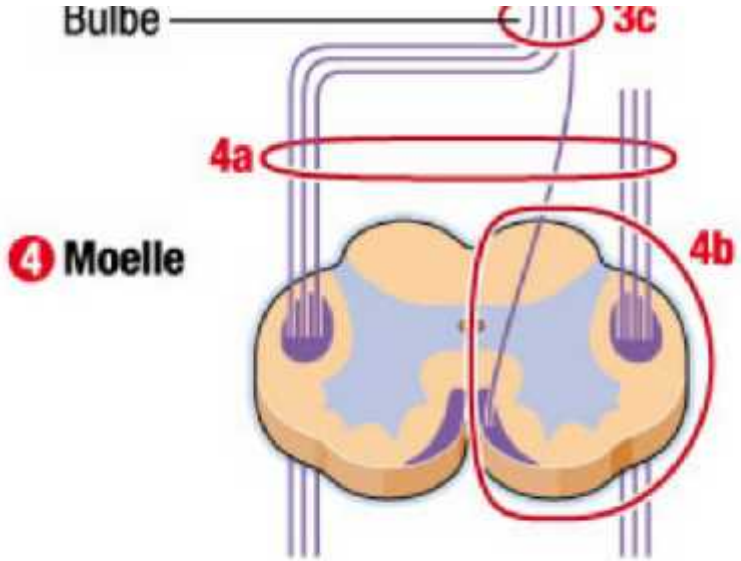
Hemiplégies par atteinte du tronc cérébral

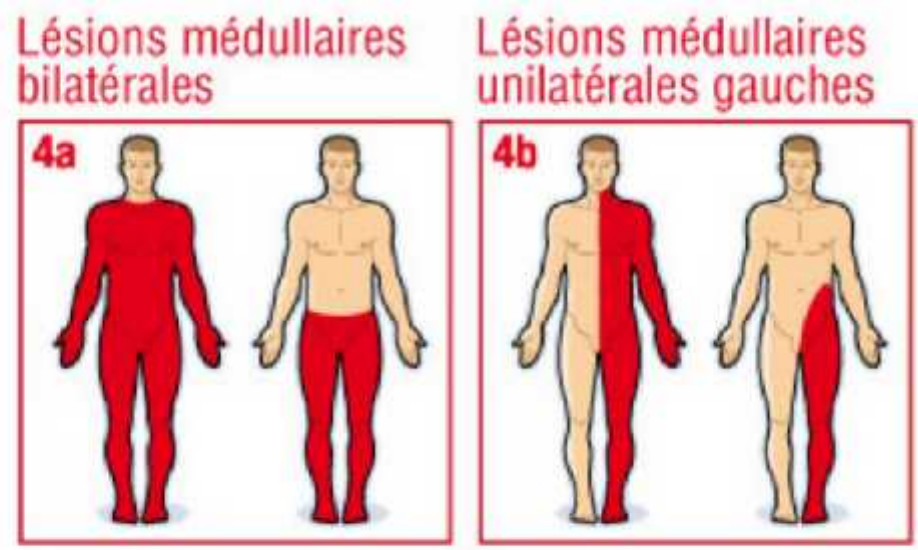




Déficit controlatéral

Atteinte médullaire





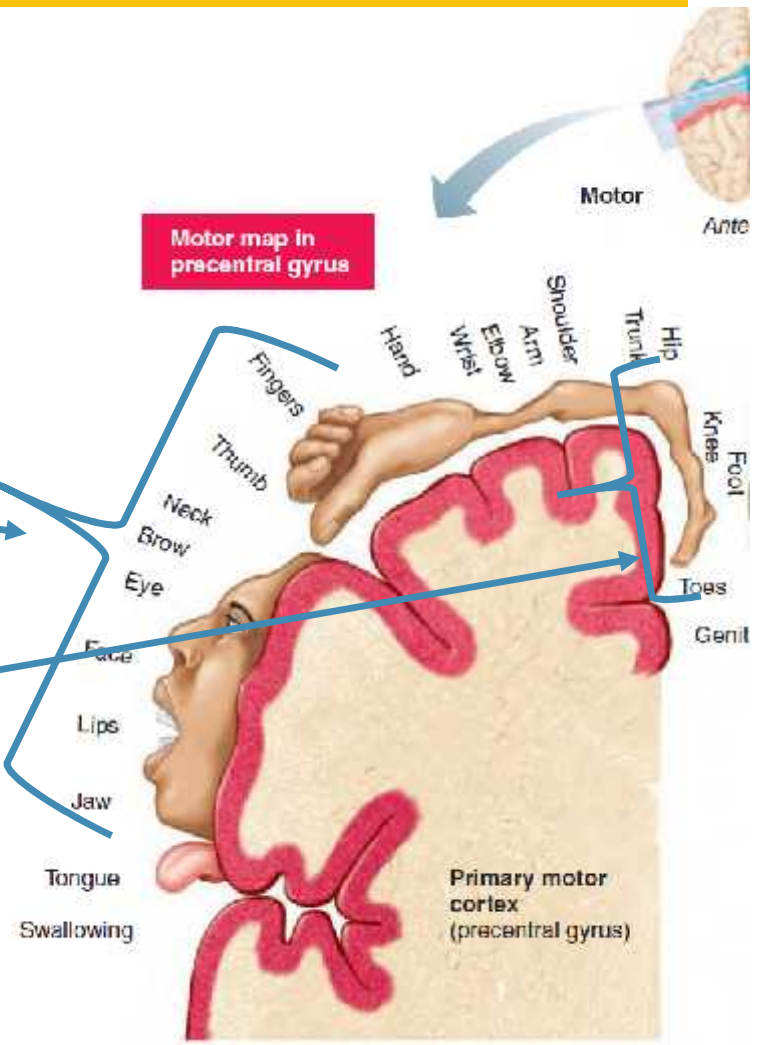
moelle cervicale moelle dorsale

Déficit bilatéral

Déficit homolatéral

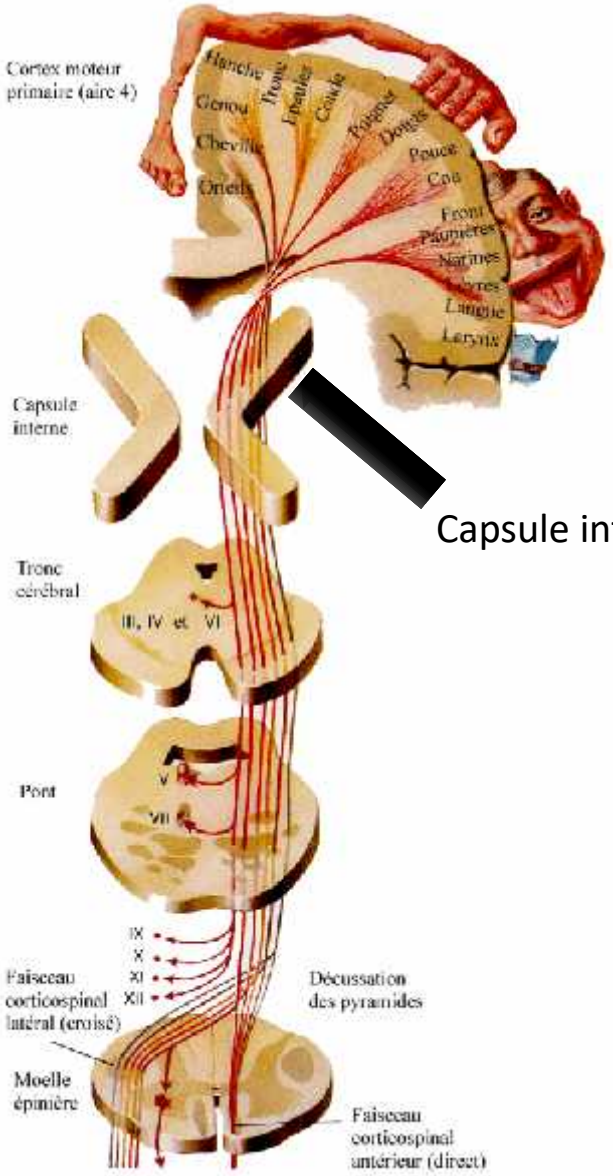
Hémiplégie corticale

- Hémicorps **controlatéral** à la lésion
- Prédominance brachio-faciale si lésion à la face externe de l'hémisphère
- Prédominance crurale si lésion à la face interne de l'hémisphère



hémiplégie capsulaire : Capsule interne

- Hémicorps **controlatéral** à la lésion
- **Proportionnelle** = égale sur tout l'hémicorps (passage de toutes les fibres pyramidales par cette région anatomique)
- Pas de trouble sensitif

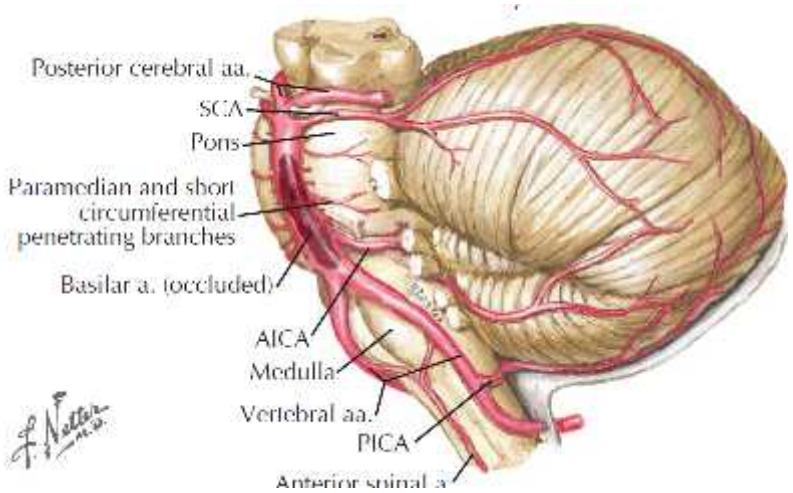


Syndromes alternes

- **Tronc cérébral**

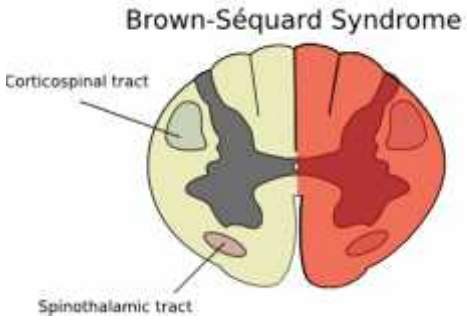
- atteinte d'un ou plusieurs **nerfs crâniens du côté** de la lésion

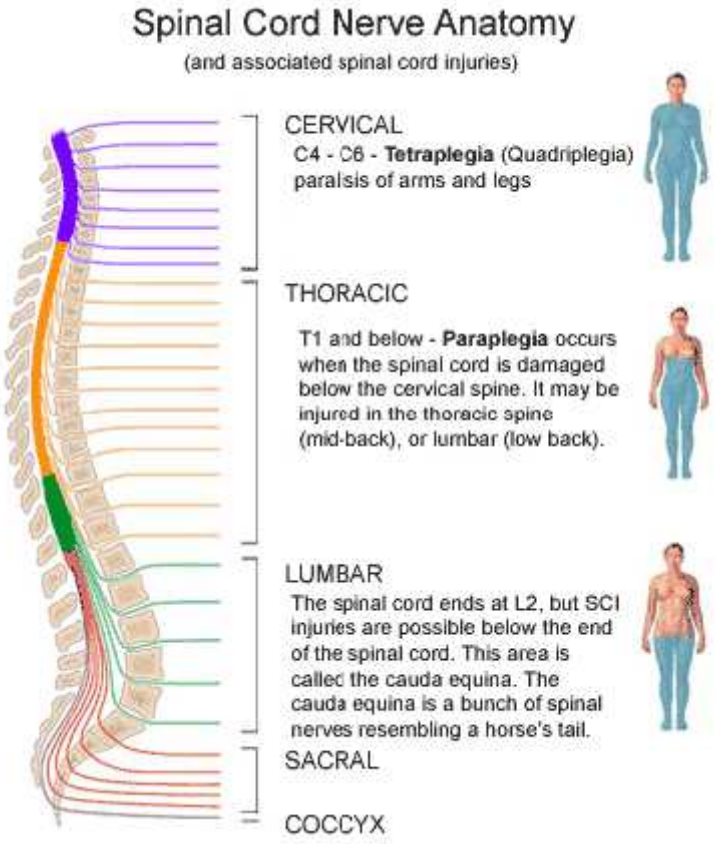
- atteinte **sensitive ou motrice controlatérale** à la lésion (hémiplégie ou hémianesthésie)



Moelle épinière :

- Lésion de la moelle cervicale → tétraplégie/parésie
- lésion de la moelle dorsale → paraplégie/parésie
- Lésion unilatérale → parlysie **homolatérale** à la lésion

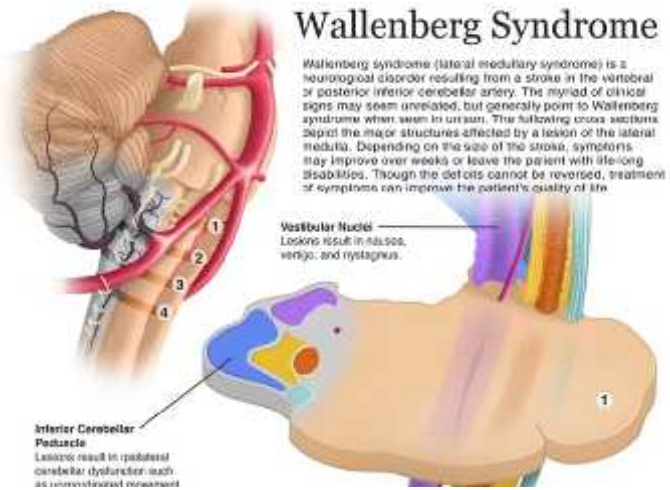




SyndromeWallenberg

- **syndrome alterne**

- Attente du tronc cérébral (partie latérale)



Du coté Homolatéral :

- **syndrome de Claude Bernard Horner** (atteinte de la voie sympathique)
- **hémisyndrome cérébelleux** : atteinte du pédoncule cérébelleux inférieur
- **atteinte du VIII** : syndrome vestibulaire avec nystagmus rotatoire
- **atteinte des nerfs (IX et X)**: troubles de phonation et de déglutition
- **atteinte du V:** anesthésie de l'hémiface

Du coté Controlatéral :

- anesthésie thermo-algique de l'hémicorps épargnant la face

Sd de Déjerine et Roussy

- Lésion thalamique
- **Hémianesthésie** controlatérale à tous les modes
- Hémiparésie modérée controlatérale
- **Hyperpathie** controlatérale de l'hémicorps associée à des paresthésies

Hyperpathie :

perception d'une douleur persistante lors de stimulations non douloureuses normalement

Syndrome de Brown Séquard

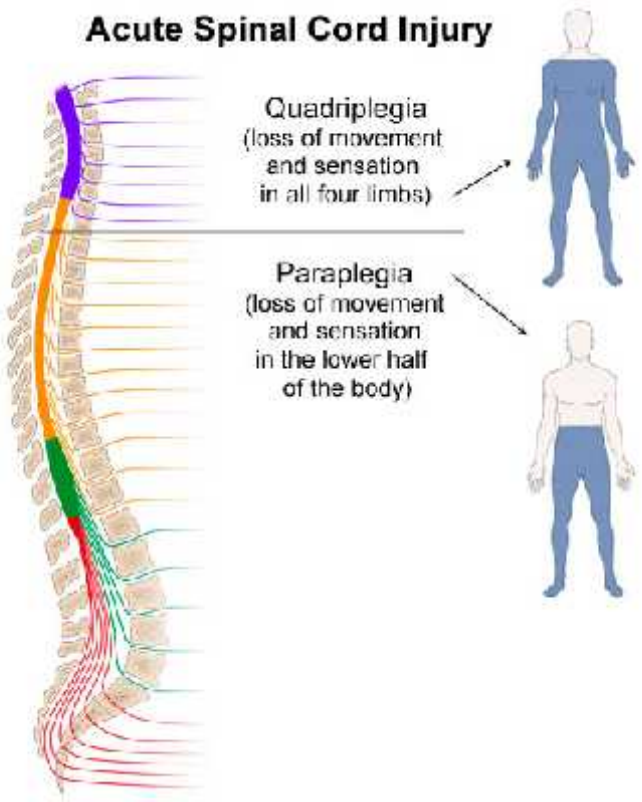
- Tableau d'hémisection de moelle
- **Du coté de la lésion :**

  Déficit moteur pyramidal
  Syndrome cordonnal postérieur (sensibilité profonde)

- **Du coté opposé à la lésion :**

  Déficit sensitif (sensibilité thermo-algésique)

Paraplégie : paralysie des deux membres inférieurs



La paraplégie flasque : stade initial des lésions médullaires aiguës

- Paralysie des membres inférieurs
- hypotonie
- abolition des réflexes ostéo-tendineux
- signe de Babinski bilatéral
- troubles sensitifs à tous les modes avec limite supérieure
- troubles sphinctériens.

La paraplégie spasmodique : succède généralement à une paraplégie flasque

- paralysie prédominant sur les fléchisseurs et les abducteurs
- hypertonie prédominant sur les extenseurs et les adducteurs
- hyper-réflectivité ostéo-tendineuse
- signe de Babinski bilatéral
- troubles sensitifs à tous les modes
- troubles sphinctériens

Diagnostic différentiel des paralysies

- impotence fonctionnelle liée aux affection ostéoarticulaires
- rétractions tendineuses
- Troubles de la sensibilité proprioceptive
- Atteinte extra pyramidale
- Simulation : examen clinique normal (diagnostic d'élimination)

claudication Médullaire = claudication intermittente spinale

- fatigabilité à la marche : au bout d'une certaine distance le malade s'arrête
- Reprise de la marche après un repos
- fatigabilité sans douleur
- A différencier de la claudication intermittente d'origine artérielle (AOMI) douloureuse avec crampe.

Merci pour votre attention